



Langerhans 細胞組織球症 Langerhans cell histiocytosis (LCH)

到達目標

- Langerhans 細胞組織球症の疫学上の特徴、喫煙との関連を説明できる
- 画像所見の特徴を説明できる
- 病理組織所見の特徴を説明できる
- 予後は比較的良好であり、禁煙のみで軽快する症例が多いことを理解する

病因・病態・疫学

Langerhans 細胞組織球症 (LCH) は、Langerhans 細胞 (Langerhans cells : LCs) が多臓器へ増殖・浸潤した原因不明の稀少疾患である。かつては好酸球性肉芽腫症、Letterer-Siwe 病、Hand-Schuller-Christian 病の3疾患をまとめてヒストチオサイトーシス X と呼ばれていたが、現在では LCH と呼ばれている。単一の臓器が障害される単一臓器型 (single-system LCH) と2つ以上の臓器が障害される多臓器型 (multi-system LCH) に分類される。

成人と小児では病気の全身分布、喫煙の関与が異なる。本項では成人の LCH について述べる。成人の肺 LCH は20~40 歳代に多く、有病率 (10 万対) は男 0.27, 女 0.07 で男性に多い (性比 4 : 1)^{1,2)}。肺 LCH は、約 90 % が有喫煙歴者であり、発症に喫煙が関与すると考えられている。骨・下垂体・皮膚・リンパ節・肝・脾・脳などに病変を形成するが、成人の肺

LCH では肺限局型 (肺 LCH) が多い¹⁻⁴⁾。

症候・身体所見

肺 LCH の主な自覚症状は、乾性咳嗽、労作時呼吸困難であり、胸痛 (気胸の合併) を認めることがある。10~20 % の症例は無症状で、多くは健診発見である。

診断・検査

肺 LCH の診断には、典型的な画像所見と病理組織所見が必要である。また、気管支肺胞洗浄液 (bronchoalveolar lavage fluid : BALF) に特異的所見を認める場合、病理組織所見と同等に扱ってよい。

a 画像所見

胸部 X 線写真では、上・中肺野優位に網状粒状影・薄壁小輪状影・浸潤影が混在する (図 1a)。進行すると奇異な形状の嚢胞を形成し、しばしば気胸を合併する。胸部 HRCT では、上・中肺野優位に 5 mm 以下の粒状影 (結節影)、索状影、小輪状、薄壁嚢胞が混在する (図 1b)。

b 呼吸機能検査所見

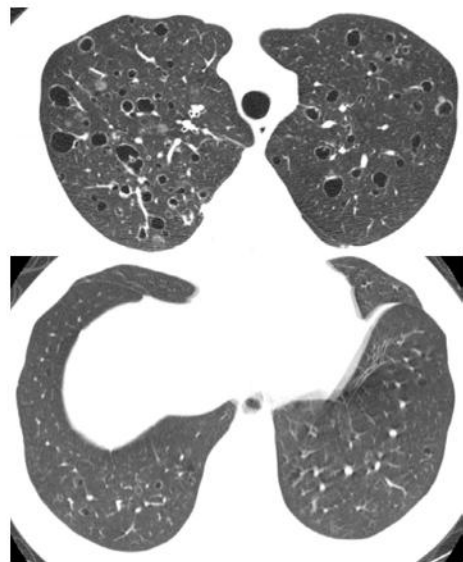
閉塞性換気障害、肺拡散能低下を示す。

c 気管支肺胞洗浄液 (BALF) 所見

主にサルコイドーシスなどの他疾患除外に役立つ。肺マクロファージが増加し、CD1a 陽性細胞 (LCs)



a.



b.

図 1 Langerhans 細胞組織球症の画像所見 (30 歳代、男性)

胸部 HRCT では上肺野優位に粒状影 (結節影)、索状影、小輪状、薄壁嚢胞が混在して認められる。